

A. ACCIÓN INMEDIATA TRAS LA EXPOSICIÓN

-  Lavar inmediatamente el área expuesta con abundante agua y jabón.

Si el área afectada es la piel: lavar inmediatamente con agua y jabón la zona afectada durante 10-15 minutos y acudir a urgencia para evaluación médica.
-  Para la exposición de las mucosas, las membranas mucosas expuestas deben lavarse con abundante agua. Los ojos se deben irrigar con solución salina o agua.

En caso de contacto ocular: irrigar con solución salina o agua limpia por al menos 15 minutos.
-  No exprimir ni frotar la herida.
-  Las pequeñas heridas y pinchazos también se pueden limpiar con un antiséptico, por ejemplo, solución de higiene de manos a base de alcohol de al menos 70%.
-  Informar inmediatamente al jefe directo o jefe de turno.
-  Acudir a Unidad de Urgencia para evaluación y manejo inicial.

B. PROCEDIMIENTOS EN URGENCIA

-  Evaluar y clasificar el riesgo.
-  Tomar exámenes basales al trabajador expuesto y a la fuente (si es posible).
-  Indicar profilaxis PEP si corresponde.
-  Completar formulario de notificación interna (Anexo 1) y DIAT (Anexo 2).
-  Registrar atención en ficha clínica (DAU).
-  Derivar a consejerías VIH e IAAS.
-  Indicar controles y seguimiento según riesgo.

IMPORTANTE !

Una vez ocurrido el accidente, se debe comunicar de forma inmediata al jefe directo. En horario inhábil será el jefe de turno.

MANEJO INMEDIATO (resumen clave)

- Piel: lavar con agua y jabón por 10-15 minutos.
- Ojos o mucosas: limpiar con suero fisiológico o agua por 15 minutos.
- No frotar ni exprimir la herida.
- Las pequeñas heridas y pinchazos pueden limpiarse con antiséptico (alcohol $\geq 70\%$).
- Comunicar de inmediato al jefe directo y acudir a urgencia.

C. PROCEDIMIENTO POSTERIOR

-  Realizar seguimiento clínico según calendario establecido.
-  Control de exámenes según riesgo (VIH, VHB, VHC y otros).
-  Evaluar adherencia y efectos adversos si recibe profilaxis.
-  Entregar apoyo psicológico y consejería.

MANEJO SEGÚN RIESGO Y PERSONA FUENTE (VIH)

PERSONA FUENTE	EXPOSICIÓN CON RIESGO	EXPOSICIÓN SIN RIESGO
 VIH (+) o Desconocida	• Consejería VIH • Eliminar VIH basal al trabajador • Recomendar PEP • Registrar en formulario DIAT • Proporcionar fármacos según protocolo	• Consejería • No se inicia PEP
 VIH (-) (Test rápido negativo)	• Consejería • Eliminar VIH basal al trabajador • Iniciar PEP si acepta (ventana 18-90 días) • Registrar en DIAT y proporcionar fármacos	• Consejería • No se recomienda PEP

ESQUEMAS ANTIRRETROVIRALES (PEP) DURACIÓN: 30 DÍAS

ESQUEMA PREFERENTE

 Tenofovir disoproxil fumarato 300 mg / Lamivudina 300 mg / Dolutegravir 50 mg (TLD): 1 comp día VO

ESQUEMA ALTERNATIVO

 Tenofovir disoproxil fumarato 300 mg / Emtricitabina 200 mg: 1 comp al día, asociado a Raltegravir 400 mg: 1 comp c/12 hrs VO (ambos por 30 días)



IMPORTANTE: Toda exposición a sangre o fluidos de riesgo es una EMERGENCIA. La profilaxis (PEP) debe iniciarse lo antes posible, idealmente antes de las 2 a 24 horas y no más allá de 72 horas postexposición.



LA PREVENCIÓN, LA ACCIÓN OPORTUNA Y EL SEGUIMIENTO
ADECUADO PROTEGEN TU SALUD Y LA DE TODOS.

¡CUIDARTE ES CUIDARNOS TODOS!

